

SABİT VE HAREKETLİ PROTETİK UYGULAMALAR HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Hasta Adı Soyadı:	T.C. Kimlik No:	Tarih: / / 20.... Saat: :
----------------------------	--------------------------	--

1. Teşhis / İşlem Planlanan Diş veya Bölge

Hekim; sabit veya hareketli protetik işlem planlanan diş/bölgeleri şema üzerinde işaretler; teşhis ve klinik planı aşağıya yazar.

Üst Çene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
Alt Çene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Teşhis / eksik diş veya bölge / protetik plan:																
Planlanan protetik işlem:	Diş üzeri sabit protez / implant üstü sabit protez / konvansiyonel hareketli protez / implant üzeri hareketli protez / diğer:															
Protez türü / materyal / özel not:	Metal-seramik / zirkonyum / e.max / lamine / parsiyel / total / locator / bar / ataşman / abutment bilgisi:															

2. Lokal Anestezi Bilgilendirmesi ve Komplikasyonları

İşlem sırasında gerekli görülürse lokal anestezi uygulanabilir. Kliniğimizde lokal anestezi amacıyla lidokain ve/veya artikain etken maddeli, adrenalini veya adrenalinsiz anestetik solüsyonlar kullanılabilir. Lokal anestezi uygulanacak bölgede sinir iletimini geçici olarak azaltır veya durdurur; uyuşukluk kişiye, uygulama bölgesine ve kullanılan ilaca göre değişmekle birlikte yaklaşık 1-4 saat sürebilir. Lokal anestezi sonrası geçici uyuşukluk, dudak/yanak/dil ısırmasına bağlı travma, enjeksiyon bölgesinde ağrı, ödem, morarma, kas spazmı, çene açmada kısıtlılık, geçici kas zayıflığı, geçici yüz felci, geçici his kaybı, anestezinin yetersiz kalması veya tekrarlanması ihtiyacı görülebilir. Nadir olarak lokal anestetiklere veya içeriğindeki maddelere bağlı alerjik reaksiyon, kaşıntı, döküntü, anjiyoödem, tansiyon değişikliği, çarpıntı, solunum güçlüğü ve anafilaksi/anafilaktik şok gelişebilir; bu durumda acil tıbbi müdahale gerekebilir.

3. SABİT PROTETİK UYGULAMALAR ☐

Kapsam: Bu bölüm diş üzeri sabit protezleri ve implant üstü sabit protezleri kapsar. Diş üzeri sabit protezlerde kuron, köprü, metal-seramik, zirkonyum, e.max, lamine, inley/onley/overlay gibi uygulamalar; implant üstü sabit protezlerde implant üstü kuron/köprü, vidalı veya simanlı protez, abutment ve protez komponentleri yer alabilir.

İşlemden beklenen faydalar: Madde kaybı, kırık, renk/şekil bozukluğu ve diş eksikliğinin giderilmesi; çiğneme, konuşma ve estetik fonksiyonun iyileştirilmesi; uygun vakalarda doğal dişlerin ve/veya implantların fonksiyona kazandırılması beklenir.

Diş üzeri sabit protezlerde özel bilgilendirme: İmplant uygulanmadığı veya diş üzeri sabit protez planlandığı durumlarda destek dişlerin prepare edilmesi/ufaltılması gerekebilir. Diş kesimi sonrasında geçici veya kalıcı hassasiyet, ağrı, pulpa irritasyonu, diş canlılığında azalma ve duruma göre kanal tedavisi ihtiyacı oluşabilir. Dişler prepare edilirken derin çürük, eski restorasyon, madde kaybı veya anatomik yakınlık nedeniyle pulpa odası açılabilir/perfore olabilir; bu durumda ilgili diş kanal tedavisi, ek restoratif işlem, plan değişikliği veya çekim gerekebilir.

İmplant üstü sabit protezlerde özel bilgilendirme: İmplant üstü sabit protezlerde implant pozisyonu ölçü/dijital tarama ile aktarılır; abutment, vida, siman veya uygun bağlantı sistemi kullanılır. Vida gevşemesi/kırılması, abutment veya protez komponent hasarı, siman artığına bağlı diş eti/implant çevresi sorunları, periimplant dokularda iltihap, protezde kırılma/çatlama ve bakım ya da parça değişimi ihtiyacı oluşabilir.

İmmediat yükleme bilgilendirmesi: Uygun vakalarda implant yerleştirildikten sonra aynı gün veya erken dönemde geçici/sabit protezle immediat yükleme planlanabilir. Bu uygulama kemik kalitesi, implant stabilitesi, kapanış ilişkisi, brüksizm/diş sıkma ve hasta uyumuna bağlıdır. İmmediat yüklemede implantın kemikle kaynaşmaması, mikromobilité, vida gevşemesi, geçici protez kırılması/çıkması, diş eti çekilmesi, estetik uyumsuzluk ve implant kaybı riski artabilir. Hasta hekim önerisi dışında sert gıda çiğnememeli, yüklenmeyi artıracak davranışlardan kaçınmalı ve kontrol randevularını aksatmamalıdır.

İşlem nasıl yapılır, nerede/kim tarafından yapılır ve tahmini süre: İşlem, hekimleri tarafından uygulanır. Diş üzeri sabit protezlerde gerekirse lokal anestezi yapılır; destek dişler hazırlanır, ölçü/dijital tarama alınır, renk seçilir, geçici restorasyon yapılabilir, prova aşamalarından sonra restorasyon simante edilir. İmplant üstü sabit protezlerde implant pozisyonu aktarılır, kanal tedavisi ihtiyacı, pulpa odası açılması/perforasyon, diş eti kanaması/çekilmesi, geçici protez düşmesi/kırılması, renk/şekil/boyut/uyum memnuniyetsizliği, yüksek kapanış, konuşma/çiğneme adaptasyon sorunu, seramik veya akrilik çatlama/kırılma, siman çözünmesi, restorasyon düşmesi, alt çürük, gıda sıkışması, periodontal/periimplant sorunlar ve protezin yenilenmesi gerekebilir.

Alternatifler: Dolgu, inley/onley/overlay, kanal tedavisi, ortodonti, mevcut protezin tamiri veya yenilenmesi, diş çekimi, hareketli protez, implant destekli sabit/hareketli protez, implant sayısının artırılması ya da tedavisiz takip seçenekleri değerlendirilebilir. Materyal olarak metal-seramik, zirkonyum, e.max, lamine veya farklı protetik seçenekler planlanabilir. Her seçenek her hasta, diş, implant ve diş eti/kemik yapısı için uygun olmayabilir.

Riskler ve komplikasyonlar: Kesin başarı, konfor, estetik memnuniyet, renk uyumu ve ömür garantisi verilemez. Diş kesimi sonrası hassasiyet, ağrı, kanal tedavisi ihtiyacı, pulpa odası açılması/perforasyon, diş eti kanaması/çekilmesi, geçici protez düşmesi/kırılması, renk/şekil/boyut/uyum memnuniyetsizliği, yüksek kapanış, konuşma/çiğneme adaptasyon sorunu, seramik veya akrilik çatlama/kırılma, siman çözünmesi, restorasyon düşmesi, alt çürük, gıda sıkışması, periodontal/periimplant sorunlar ve protezin yenilenmesi gerekebilir.

İşlem yapılmazsa ne olur: Gerekli sabit protetik tedavi yapılmazsa dişte kırılma, çürük ilerlemesi, hassasiyet/ağrı, kanal tedavisi veya çekim ihtiyacı, estetik/fonksiyon kaybı, komşu dişlerde devrilme, karşıt dişte uzama, kapanış bozukluğu, gıda birikimi, diş eti problemleri ve çene eklemi/çiğneme sorunları gelişebilir. İmplant üstü protez yapılmazsa implantın fonksiyon kazanması gecikebilir veya planlanan fayda sağlanamayabilir.

İşlem öncesi/sonrası dikkat ve hastanın belirtmesi gereken durumlar: Hasta sistemik hastalıklarını, alerjilerini, kullandığı ilaçları, gebelik durumunu, brüksizm/diş sıkma alışkanlığını ve daha önce yaşadığı protez/implant problemlerini hekime bildirmelidir. Geçici protezleri dikkatli kullanmalı, sert/yapışkan gıdalardan kaçınmalı, ağız hijyeni, ara yüz temizliği ve implant çevresi bakımını yapmalıdır. Yüksek kapanış, ağrı, protez hareketi, vida gevşemesi, kırık, gıda sıkışması, diş eti kanaması veya implant çevresinde şişlik olduğunda kliniğe bilgi vermelidir.

4. HAREKETLİ PROTETİK UYGULAMALAR □

Kapsam: Bu bölüm konvansiyonel hareketli protezleri ve implant üzeri hareketli protezleri kapsar. Konvansiyonel hareketli protezler total protez, parsiyel protez, kroşeli veya hassas tutuculu protezleri; implant üzeri hareketli protezler locator, bar veya benzeri ataşman sistemleriyle desteklenen protezleri içerebilir.

İşlemden beklenen faydalar: Eksik dişlerin ve çevre dokuların yerine konması; çiğneme, konuşma, dudak-yüz desteği ve estetik görünümün iyileştirilmesi; implant üzeri hareketli protezlerde tutuculuk ve stabilitenin artırılması beklenir.

Konvansiyonel hareketli protezlerde özel bilgilendirme: Total veya parsiyel protezlerde tutuculuk ve konfor; damak/çene kemiği yapısı, tükürük miktarı, kas kontrolü, kalan dişlerin durumu ve hastanın adaptasyonuna bağlıdır. İlk günlerde vuruk, konuşma ve çiğneme alışkanlığında değişiklik, tükürük artışı veya bulantı hissi olabilir; vuruk düzeltmeleri ve kontrol seansları gerekebilir.

İmplant üzeri hareketli protezlerde özel bilgilendirme: İmplant üzeri hareketli protezlerde locator, bar, ataşman lastiği veya benzeri tutucu parçalar kullanılabilir. Bu parçalar zamanla aşınabilir, tutuculuk azalabilir, gevşeme/kırılma veya parça değişimi gerekebilir. İmplant çevresi hijyen ve düzenli kontroller aksatılırsa periimplant dokularda iltihap, kemik kaybı ve implant/protez sorunları gelişebilir.

İşlem nasıl yapılır, nerede/kim tarafından yapılır ve tahmini süre: İşlem, hekimleri tarafından uygulanır. Hareketli protezlerde ölçü, özel kaşık, kapanış kaydı, diş dizimi, prova ve teslim aşamaları yapılabilir. Parsiyel protezlerde kroşe veya hassas tutucu; implant üzeri hareketli protezlerde locator, bar veya benzeri ataşman sistemleri kullanılabilir. Her klinik seans çoğunlukla 20-60 dakika sürebilir; toplam tedavi süresi ölçü/prova sayısı, laboratuvar süreci, implant/ataşman sistemi ve doku uyumuna göre birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişebilir. Teslim sonrası vuruk alma, kapanış düzenleme, astarlama ve bakım seansları gerekebilir.

Alternatifler: Tedavisiz takip, mevcut protezin tamiri/astarlanması, yeni hareketli protez, sabit köprü, implant destekli sabit protez, implant sayısının artırılması, farklı ataşman sistemleri veya ileri cerrahi/protetik planlar değerlendirilebilir. Her seçenek her hasta, kemik/doku yapısı, implant sayısı ve ekonomik/klinik koşul için uygun olmayabilir.

Riskler ve komplikasyonlar: Kesin tutuculuk, konfor, konuşma/çiğneme uyumu, estetik memnuniyet ve ömür garantisi verilemez. İlk dönemde vuruk, yara, ağrı, tükürük artışı, bulantı refleksi, konuşma ve çiğneme adaptasyon sorunu, protezin oynaması, koku, protez dişi düşmesi, akrilik/metal parça kırılması, kroşe veya ataşman gevşemesi/kırılması görülebilir. İmplant üzeri hareketli protezlerde ataşman lastiklerinin aşınması, tutuculuk azalması, locator/bar parçalarının gevşemesi/kırılması, implant çevresi iltihap, bakım ve parça değişimi ihtiyacı oluşabilir.

İşlem yapılmazsa ne olur: Eksik dişler tamamlanmadığında çiğneme etkinliği, konuşma, estetik görünüm ve yüz-dudak desteği etkilenebilir. Komşu dişlerde devrilme, karşıt dişte uzama, kapanış bozukluğu, gıda birikimi, diş eti problemleri ve çene eklemi/çiğneme sorunları gelişebilir. Tam dişsizlikte protezsiz kullanıma beslenme, fonksiyon ve konforu azaltabilir.

İşlem öncesi/sonrası dikkat ve hastanın belirtmesi gereken durumlar: Hasta sistemik hastalıklarını, alerjilerini, kullandığı ilaçları, ağız kuruluğu, bulantı refleksi, diş sıkma ve implant/protez geçmişini hekime bildirmelidir. Hareketli protezlerde ilk günlerde uyum süreci olabileceğini bilmeli; vuruk veya ağrı olduğunda protezi kendisi düzeltmeye çalışmadan kliniğe başvurmaldır. Protezi temizleme, hekimin önerisine göre gece çıkarma/saklama, özel fırça veya temizleyici kullanma ve düzenli kontrol/ataşman bakım randevularına gelme sorumluluğu hastaya aittir.

5. Kullanılabilecek İlaçlar, Materyaller ve İstenmeyen Etkiler

İşlem öncesi veya sonrası gerekli görülürse lokal anestezi, ağrı kesici, antienflamatuvar, antibiyotik, antiseptik gargara veya hekimin uygun gördüğü diğer ilaçlar kullanılabilir/reçete edilebilir. Bu ilaçlara, kullanılan lokal anesteziklere, ölçü maddelerine, simanlara, akrilik/rezin/metal/seramik materyallere veya implant/protez komponentlerine bağlı mide bulantısı, ishal, mide rahatsızlığı, baş dönmesi, uyku hali, cilt döküntüsü, kaşıntı, kontakt irritasyon, alerjik reaksiyon ve nadiren anafilaksi gelişebilir. Hasta daha önce ilaç, lokal anestezi, antibiyotik, ağrı kesici, lateks, ölçü maddesi veya dental materyal alerjisi yaşadığına hekime bildirmelidir. Solunum güçlüğü, yaygın döküntü/kaşıntı, dudak-dil-boğaz şişliği, baygınlık hissi veya hızlı kötüleşme olursa acil tıbbi yardım alınmalıdır.

6. Onam Beyanı

Yukarıdaki bilgileri okudum. Sabit ve/veya hareketli protetik uygulamaların nasıl yapılacağı, diş üzeri ve implant üzeri seçeneklerin kapsamı, tahmini süreleri, işlemden beklenen faydaları, alternatifleri, yapılmazsa oluşabilecek sonuçları, lokal anestezi ve ilaç/materyal riskleri, işlem öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar, riskler ve komplikasyonlar hakkında hekimim tarafından anlayabileceğim şekilde bilgilendirildim. Bu formdaki bilgiler tarafıma hekimim tarafından sözlü olarak açıklanmıştır. Soru sorma fırsatı buldum, sorularım yanıtlandı. Tedavilerin kesin başarı, tutuculuk, konfor ve estetik memnuniyet garantisi taşımadığını; protez uyumu ve ömrünün kişisel anatomik koşullara, hijyene, kullanım alışkanlıklarına ve düzenli kontrollere bağlı olduğunu anladım. Belirtilen protetik işlemlerin uygulanmasını kabul ediyorum.

7. İmza Alanı

Hasta el yazısı ile:

(noktalı alana “okudum anladım onaylıyorum” yazınız)

Hasta / Yasal Temsilci - Ad Soyad / İmza / Tarih:

Hekim - Ad Soyad / İmza / Tarih:

Yasal temsilci imzasında yakınlık derecesi ve temsil nedeni hasta dosyasına ayrıca kaydedilir.